

Var anglais :

1. *Concernant les fonctions oropharyngées, la réponse suivante est incorrecte :
 - a. Conduit de passage de l'air ou des aliments
 - b. Contribue à la phase pharyngée de la déglutition
 - c. Assure une défense locale et une immunité contre les intrus nuisibles dans les voies respiratoires et alimentaires
 - d. Fait partie du conduit vocal pour certains sons de la parole
 - e. Contribue à l'appréciation des odeurs
2. *La cause la plus fréquente de paralysie bilatérale du nerf laryngé récurrent est :
 - a. Un traumatisme laryngé
 - b. Une lésion iatrogène chirurgicale en cas de thyroïdectomie totale
 - c. Une masse tumorale s'étendant dans la partie supérieure du médiastin
 - d. Polyneuropathie toxique des nerfs laryngés récurrents
 - e. Laryngite sous-glottique aiguë
3. *Le symptôme le plus important de l'otospongiose est :
 - a. Vertige
 - b. Perte auditive de transmission
 - c. Perte auditive neurosensorielle
 - d. Plénitude auditive
 - e. Acouphènes
4. *Le traitement électif du cholestéatome est
 - a. Antibiothérapie
 - b. Chimiothérapie
 - c. Radiothérapie
 - d. Chirurgie
 - e. Politique d'attente et de scanner
5. *La cloison nasale divise le nez en :
 - a. Fosse nasale supérieure et inférieure
 - b. Fosse nasale droite et gauche
 - c. Fosse nasale latérale et médiale
 - d. Quatre cavités 2 supérieures et 2 inférieures
 - e. Quatre cavités, 2 médiales et 2 latérales

6. *Sinus maxillaire
 - a. S'ouvre dans la partie postérieure de l'infundibulum ethmoïdal dans le méat moyen
 - b. S'ouvre dans le méat supérieur
 - c. Son innervation provient du NC IX
 - d. C'est le plus petit sinus
 - e. A une capacité de 5 ml
7. Les relations du méat acoustique externe sont
 - a. Supérieurement – fosse crânienne moyenne
 - b. Postérieurement – cellule aérienne mastoïdienne et nerf facial
 - c. Inférieurement – glande parotide
 - d. Antérieurement – articulation temporo-mandibulaire
 - e. Supérieurement – cellules aériennes mastoïdiennes et nerf facial
8. La trompe d'Eustache (pharyngotympanique) :
 - a. Relie la cavité tympanique au nasopharynx
 - b. Partie osseuse – 1/3 lat
 - c. Partie fibrocartilagineuse – 2/3 médial
 - d. Torus tubaris à l'extrémité pharyngée
 - e. Cellules zygomatiques dans la partie médiane
9. Les osselets de l'oreille moyenne sont :
 - a. Marteau
 - b. Tenseur du tympan
 - c. Enclume
 - d. Étrier
 - e. Stapedius
10. Les facteurs prédisposant à l'otite moyenne aiguë suppurée sont :
 - a. Crises récurrentes de rhume, d'infections des voies respiratoires supérieures et de fièvre exanthématique
 - b. Infections des amygdales et des végétations adénoïdes
 - c. Tympanosclérose chronique
 - d. Allergie nasale
 - e. Tumeurs du nasopharynx, tamponnement du nez ou du nasopharynx pour épistaxis

11. Les signes de mastoïdite aiguë sont :

- a. Sensibilité mastoïdienne
- b. Écoulement auriculaire : écoulements mucopurulents ou purulents
- c. Affaissement de la paroi inférieure
- d. Gonflement au dessus de la mastoïde
- e. Perte auditive – type de transmission

12. Les symptômes de l'otospongiose sont :

- a. Perte auditive – type neurosensoriel bilatéral
- b. Paracusis willisii – le patient entend mieux dans un environnement bruyant que dans un environnement calme
- c. Acouphènes
- d. Vertige
- e. Parole douce, monotone et bien modulée

13. Diagnostic différentiel de l'otospongiose :

- a. Otite moyenne séreuse
- b. Tympanosclérose
- c. Fixation attique de la tête du marteau
- d. Neurinome de l'acoustique
- e. Discontinuité ossiculaire

14. Les principaux symptômes de la maladie de Ménière sont :

- a. Vertiges épisodiques
- b. Paracusis willisii
- c. Perte auditive fluctuante
- d. Acouphènes
- e. Sensation de plénitude dans l'oreille concernée

15. Innervation du larynx :

- a. Moteur : nerf laryngé récurrent
- b. Sensitif : nerf laryngé interne (audessus de la corde vocale)
- c. Moteur : nerf laryngé récurrent (sous la corde vocale)
- d. Moteur : nerf laryngé récurrent (audessus de la corde vocale)
- e. Sensoriel : nerf laryngé récurrent (sous la corde vocale)

16. Traitement de la laryngite hyperémique chronique :

- a. Élimination de l'infection des voies respiratoires supérieures ou inférieures
- b. Evitement des facteurs irritants
- c. Chirurgie
- d. Repos de la voix et orthophonie
- e. Expectorants

17. Les lésions congénitales du larynx sont :

- a. Laryngomalacie
- b. Hémangiome sousglottique
- c. Fente laryngoœsophagienne
- d. Pectus excavatum
- e. Larynx

18. Traitement de la cordite polypoïde (œdème de Reineke) :

- a. Arrêt du tabac
- b. Chirurgie : cordectomie
- c. Médicaments antireflux
- d. Thérapie vocale préopératoire
- e. Chirurgie : stripping des cordes vocales

19. Les tumeurs bénignes du larynx sont :

- a. Carcinome épidermoïde
- b. Chondrome
- c. Hémangiome
- d. Tumeur à cellules granuleuses
- e. Tumeur glandulaire

20. Étiologie du cancer du larynx :

- a. Tabac, alcool
- b. Traumatisme cervical
- c. Radiation antérieure
- d. Facteurs génétiques
- e. Exposition professionnelle

21. Les symptômes du cancer de la glotte sont :

- a. L'enrouement est un symptôme précoce
- b. L'enrouement est un symptôme tardif
- c. Stridor et obstruction laryngée aux stades avancés
- d. Stridor et obstruction laryngée aux stades précoces
- e. Mal de gorge

22. Types de cordectomies :

- a. Type I une cordectomie sousépithéliale, qui est une résection de l'épithélium
- b. Type II une cordectomie sousligamentaire, qui est une résection de l'épithélium, de l'espace de Reinke et de la voix ligament;
- c. Type III cordectomie transmusculaire, qui passe par le muscle vocalise
- d. Type IV cordectomie totale
- e. Type Va cordectomie étendue, qui englobe la corde vocale controlatérale et la corde vocale antérieure commissure
- f. Type Vb cordectomie étendue, qui inclut l'aryténoïde
- g. Type Vc cordectomie étendue, qui englobe la sousglotte
- h. Type Vd cordectomie étendue, qui inclut le ventricule

23. Les indications de la trachéotomie sont :

- a. Obstruction respiratoire
- b. Sécrétions retenues
- c. Insuffisance respiratoire
- d. Pubérophonie
- e. Enrouement

24. Les types de trachéotomie sont :

- a. Trachéotomie haute ; audessus du niveau de l'isthme thyroïdien
- b. Trachéotomie haute : à travers les anneaux II et III
- c. Trachéotomie moyenne : à travers les anneaux II et III
- d. Trachéotomie moyenne : sous le niveau de l'isthme thyroïdien
- e. Trachéotomie basse : sous le niveau de l'isthme thyroïdien

25. Les drains du sinus frontal

- a. Dans le méat supérieur
- b. Dans le récessus frontal (55 %)
- c. Au dessus mais pas dans l'infundibulum (30 %)
- d. Dans l'infundibulum (15 %)
- e. Au dessus de la bulle ethmoïdale

26. Les fonctions des sinus paranasaux sont :

- a. Climatisation de l'air inspiré : réchauffement et humidification
- b. Résonance vocale
- c. Isolants thermiques – protection des structures délicates de l'orbite et du crâne
- d. Drainage nasal
- e. Allègement des os du crâne

27. Les caractéristiques cliniques de la sinusite maxillaire aiguë sont :

- a. Symptômes constitutionnels : fièvre, malaise général
- b. Maux de tête
- c. Douleur – sur la mâchoire supérieure, parfois dans la région supraorbitaire ipsilatérale
- d. Sensibilité (la pression sur la paroi antérieure de l'antre produit de la douleur)
- e. Écoulement postnasal (pus sur le palais dur lors de la rhinoscopie antérieure)

28. Les complications de la sinusite maxillaire aiguë sont :

- a. Infection profonde du cou
- b. Sinusite subaiguë ou chronique
- c. Ostéite ou ostéomyélite
- d. Cellulite ou abcès orbitaire, névrite optique
- e. Thrombose du sinus caverneux

29. Les caractéristiques cliniques de la sinusite ethmoïdale aiguë sont :

- a. Douleur sur l'arête du nez, médiale et profonde par rapport à l'arcade sourcilière ; aggravée par le mouvement
- b. Œdème des paupières
- c. Enrouement
- d. Écoulement nasal
- e. Gonflement du cornet

30. L'anneau de Waldeyer est constitué de :

- a. Amygdale nasopharyngée ou végétations adénoïdes
- b. Amygdales palatines
- c. Amygdales linguales
- d. Amygdales gastriques
- e. Amygdales mastoïdiennes
- f. Amygdales tubaires (dans la fosse de Rosenmüller)

31. L'hypopharynx se subdivise cliniquement en trois régions

- a. Le sinus piriforme (fosse) se situe de chaque côté du larynx et se développe à partir du pli pharyngoépiglottique... extrémité de l'œsophage
- b. Région postcricoïde : la partie de la paroi antérieure du laryngopharynx située entre les parois supérieure et inférieure bords de la lame cricoïde
- c. Paroi pharyngée postérieure : s'étend du niveau de l'os hyoïde au niveau du cricoaryténoïde
- d. Corde vocale
- e. Pli ventriculaire

32. *Les fonctions de l'hypopharynx sont :

- a. Conduit de passage de l'air ou des aliments
- b. Respiration
- c. Aide à la phase pharyngée de la déglutition
- d. Climatisation de l'air inspiré : réchauffement et humidification
- e. Fait partie du conduit vocal pour certains sons de la parole

33. Les complications de l'abcès périamygdalien (angine) sont :

- a. Abscess parapharyngé
- b. Œdème du larynx
- c. Septicémie
- d. Pneumopathie
- e. Hémorragie spontanée de la veine carotide ou de l'artère jugulaire

34. Sur la paroi latérale des fosses nasales, on trouve :

- a. Le méat moyen
- b. La cloison nasale
- c. Le méat inférieur
- d. L'ostium du sinus maxillaire
- e. Les végétations adénoïdes

35. La déviation de la cloison nasale peut entraîner :

- a. Sinusite
- b. Respiration orale
- c. Hypo/ansomie

36. *Concernant l'anatomie du pharynx, laquelle des affirmations suivantes est incorrecte :

- a. Il s'étend de la base du crâne jusqu'au bord inférieur du cartilage cricoïde en avant et au bord inférieur de C6 en arrière
- b. La partie la plus large (5 cm) se situe au niveau de l'hyoïde
- c. La partie la plus étroite (1,5 cm) se trouve à son extrémité caudale
- d. Le pharynx est divisé en 3 parties : naso/oro et laryngopharynx
- e. Le pharynx mesure plus de 20 cm de longueur

37. *Les structures de la paroi pharyngée sont les suivantes, à une exception près. Indiquer l'exception :

- a. Muqueuse
- b. Aponévrose pharyngée
- c. Fascia musculaire
- d. Fascia buccopharyngé
- e. Périoste

38. L'anneau de Waldeyer est composé des éléments suivants sauf un

- a. Glandes sousmaxillaires
- b. Amygdales nasopharyngées ou végétations adénoïdes
- c. Amygdales palatines
- d. Amygdales tubaires (dans la fosse de Rosenmüller)
- e. Nodules (sur la paroi postpharyngée)

39. *Les fonctions nasopharyngées sont les suivantes sauf une

- a. Conduit pour l'air
- b. Ventile l'oreille moyenne par la trompe d'Eustache
- c. Résonance
- d. Passage pour les aliments et les liquides
- e. Canal de drainage

40. Les symptômes de l'adénoïte auriculaire sont :

- a. Obstruction tubaire
- b. Sinusite
- c. Crises récurrentes d'otite moyenne aiguë
- d. Écoulement nasal
- e. Otite moyenne séreuse

41. Concernant l'angiofibrome nasopharyngé juvénile, les affirmations suivantes sont correctes :

- a. Cause exacte inconnue
- b. Âge et sexe (exclusivement chez les hommes dans la tranche d'âge 40-60 ans)
- c. Se manifeste par une obstruction nasale progressive et un langage nasal
- d. La biopsie est associée à un saignement profond et doit donc être évitée
- e. Le traitement est toujours chirurgical

42. Concernant le cancer du nasopharynx, les affirmations suivantes sont correctes :

- a. Début à l'âge : de la 5e à la 7e décennie, mais peut concerner des groupes d'âge plus jeunes.
- b. Les métastases ganglionnaires cervicales peuvent être la seule manifestation.
- c. Les symptômes et signes otologiques sont représentés par une surdité de transmission, séreuse et suppurée. otite moyenne
- d. Les symptômes ophtalmoneurologiques sont toujours présents au début
- e. Les métastases à distance se trouvent dans la trompe d'Eustache

43. Lesquels des symptômes suivants sont des symptômes d'amygdalite aiguë ?

- a. Mal de gorge
- b. Difficulté à avaler
- c. Respiration buccale
- d. Fièvre
- e. Mal d'oreille

44. Lesquelles des complications suivantes sont des complications de l'amygdalite aiguë ?

- a. Strabisme convergent
- b. Rhumatisme articulaire aigu
- c. Amygdalite chronique
- d. Glomérulonéphrite aiguë
- e. Endocardite bactérienne subaiguë

45. La DD d'une amygdalite aiguë est réalisée avec :

- a. Amygdalite membraneuse
- b. Diphtérie
- c. Rhinite
- d. Angine de Vincent
- e. Infections mononucléose

46. La DD de l'amygdalite aiguë est réalisée avec

- a. Sinusite
- b. Manifestations buccopharyngées dans l'agranulocytose
- c. Manifestations buccopharyngées dans la leucémie
- d. Ulcères aphteux
- e. Tumeur maligne de l'amygdale

47. Concernant la tumeur maligne de l'hypopharynx, lesquelles des affirmations suivantes sont correctes ?

- a. Les signes cliniques sont représentés par une dysphagie progressive, une malnutrition, une perte de poids, une modification de la voix et une dysphonie
- b. L'examen au miroir peut ne pas être utile
- c. Le site d'origine le plus fréquent est la région sousglottique
- d. Le pronostic est mauvais
- e. Chirurgie, radiothérapie et thérapie combinée

48. *Les nerfs olfactifs (1220) qui traversent la lame criblée et se terminent dans le :

- a. Lobe frontal
- b. Lobe temporal
- c. Lobe olfactif
- d. Lobe pariétal
- e. Bulbe olfactif

49. Le rinophyma est :

- a. Une masse bénigne à croissance lente
- b. Une tumeur maligne à croissance lente
- c. Il s'agit d'une hypertrophie des glandes sébacées de la pointe du nez
- d. Elle est traitée par excision chirurgicale ou par laser CO2.
- e. Apparaît en raison de l'hypertrophie des glandes sudoripares du bout du nez

50. L'atrésie des choanes :

- a. Peut être uni, bilatéral, complet, incomplet, osseux (90 %) ou membraneux (10 %)
- b. Elle est toujours bilatérale, complète, osseuse ou membraneuse.
- c. Il s'agit d'une urgence en cas d'atrésie choanale bilatérale.
- d. L'un des signes diagnostiques est l'absence de bulles d'air dans l'écoulement nasal.
- e. L'impossibilité de passer un cathéter du nez au pharynx est un signe important.

Var 2 anglais :

1. *Un kyste dermoïde est :
 - a. Une tumeur maligne
 - b. Une tumeur congénitale
 - c. Une infection
 - d. Une collecte de sang
 - e. Signe de consommation

2. *Dans le méat moyen, ouvrez les sinus suivants :
 - a. Sinus ethmoïdaux maxillaires, frontaux et antérieurs
 - b. Sinus ethmoïdaux postérieurs
 - c. Sinus sphénoïdal
 - d. Sinus caverneux
 - e. Sinus tympanique

3. Hématome septal :
 - a. Accumulation de sang sous le périchondre ou le périoste de la cloison nasale.
 - b. Elle peut être causée par un traumatisme nasal ou une intervention chirurgicale.
 - c. Le traitement consiste en une aspiration à l'aide d'une aiguille stérile de gros calibre.
 - d. Incision et drainage des hémorragies plus importantes par méchage nasal bilatéral.
 - e. Accumulation de tissu conjonctif.

4. Peau nasale, quelles affirmations sont correctes ?
 - a. Peau fine et librement mobile, recouvrant les os du nez
 - b. Peau fine avec de nombreuses glandes sébacées, recouvrant l'os du nez et les cartilages latéraux inférieurs
 - c. Peau épaisse, adhérente et riche en glandes sébacées recouvrant les cartilages alaires
 - d. Peau fine et adhérente recouvrant les cartilages alaires
 - e. Peau épaisse avec de nombreuses glandes sébacées, recouvrant l'os du nez et les cartilages latéraux supérieurs

5. Rhinosclérome :
 - a. L'étiologie est un bacille Gram négatif – Klebsiella Rhinoscleromatis
 - b. L'étiologie est un Gram positif – Staphylococcus aureus
 - c. Les stades cliniques sont : atrophique, granulomateux, cicatriciel
 - d. Un diagnostic certain est posé par biopsie
 - e. Traité par streptomycine et tétracycline
6. Traitement de la rhinite allergique : les éléments suivants sont corrects :
 - a. Éviter l'allergène
 - b. Surexposition à l'allergène
 - c. Antihistaminiques
 - d. Corticostéroïdes (oraux et topiques)
 - e. Radiothérapie
7. Les symptômes de la rhinite vasomotrice sont :
 - a. Respiration sifflante
 - b. Rhinorrhée excessive
 - c. Obstruction nasale
 - d. Écoulement post nasal
 - e. Toux
8. Les causes locales d'épistaxis sont :
 - a. Un traumatisme / un corps étranger
 - b. Infections
 - c. Tumeurs du nez et des sinus paranasaux
 - d. Chaleur
 - e. Froid
9. Épistaxis postérieure :
 - a. Provient principalement de la partie postérosupérieure de la fosse nasale
 - b. Survient spontanément, souvent en raison d'une hypertension ou d'une artériosclérose
 - c. La cause la plus fréquente est un traumatisme
 - d. Survient principalement chez les enfants ou les jeunes adultes
 - e. Légère et facile à contrôler

10. Complications de la sinusite frontale :

- a. Cellulite orbitaire
- b. Ostéomyélite de l'os frontal
- c. Méningite, abcès extradural ou abcès du lobe frontal
- d. Nécrose du sinus maxillaire
- e. Conjonctivite aiguë

11. Affirmation correcte concernant la laryngomalacie :

- a. Anomalie laryngée congénitale la plus courante (50-75 %)
- b. Cause la plus fréquente de stridor chez l'adulte
- c. Prédominance masculine 2:1
- d. Flaccidité du tissu laryngé supraglottique
- e. Caractérisé par un affaissement vers l'intérieur des structures du pharynx

12. Les hémangiomes sousglottiques sont :

- a. Asymptomatiques jusqu'à 12 mois
- b. 50 % ont des hémangiomes cutanés associés
- c. Stridor mais un cri normal
- d. Masse bleu rosâtre sous les cordes vocales
- e. Biopsie – fortement indiquée

13. *L'épiglotte est formée par :

- a. Muscle
- b. Os
- c. Cartilage fibreux
- d. Tissu adipeux
- e. Peau

14. *La cause la plus fréquente de paralysie bilatérale du nerf laryngé récurrent est :

- a. Un traumatisme laryngé
- b. Une lésion iatrogène chirurgicale en cas de thyroïdectomie totale due à un carcinome de la glande thyroïde
- c. Une masse tumorale s'étendant dans la partie supérieure du médiastin
- d. Une polyneuropathie toxique des nerfs laryngés récurrents
- e. Une laryngite sous glottique aiguë

15. Les fonctions du larynx sont :

- a. Phonation
- b. Respiration
- c. Protection des voies respiratoires inférieures
- d. Fixation thoracique
- e. Expectoration

16. Voici les lésions intracrâniennes de l'otite moyenne :

- a. Abscès extradural
- b. Pétrosite
- c. Méningite
- d. Labyrinthite
- e. Abscès cérébral

17. Les abcès liés à une infection mastoïdienne sont

- a. Abscès postauriculaire
- b. Abscès zygomatique
- c. Abscès de Bezold
- d. Pétrosite
- e. Cellulite orbitaire

18. Les symptômes de l'adénoïdite auriculaire ne sont pas :

- a. Obstruction tubaire
- b. Sinusite
- c. Crises récurrentes d'otite moyenne aiguë
- d. Écoulement nasal
- e. Otite moyenne séreuse

19. *L'épiglotte est formée par :

- a. Muscle
- b. Os
- c. Cartilage fibreux
- d. Tissu adipeux
- e. Peau

20. Lesquelles des affirmations suivantes sont correctes :

- a. Dans le test de Weber, le diapason est placé sur le processus mastoïde
- b. Dans le test de Weber, un patient ayant une audition normale localise le son soit au centre de la tête, soit également dans les deux oreilles
- c. Dans le test de Weber, un patient souffrant d'une perte auditive de transmission unilatérale localise le son dans l'oreille affectée
- d. Dans le test de Weber, un patient souffrant d'une perte auditive neurosensorielle localise le son dans l'oreille affectée
- e. Dans le test de Weber, un patient souffrant d'une perte auditive neurosensorielle localise le son dans l'oreille saine

21. Le diagnostic différentiel de l'amygdalite aiguë est réalisé avec

- a. Ulcères apthiques
- b. Tumeur maligne de l'amygdale
- c. Sinusite
- d. Manifestations bucopharyngées dans l'agranulocytose
- e. Manifestations bucopharyngées dans la leucémie

22. L'otospongiose est caractérisée par :

- a. Une altération de la fonction de la trompe d'Eustache
- b. Acouphènes
- c. Hyalinisation et calcification du tissu conjonctif sousépithélial, dépôts crayeux blancs dans le promontoire et osselets
- d. Perte auditive de transmission
- e. Paracusis willisii

23. La laryngite chronique non spécifique ne peut PAS être :

- a. Catarale
- b. Causé par tbc
- c. Type hypertrophique rouge et blanc
- d. Atrophique
- e. Causée par la syphilis

24. L'anneau de Waldeyer n'est PAS composé des éléments suivants :

- a. Amygdale nasopharyngée ou végétations adénoïdes
- b. Amygdales palatines
- c. Amygdales linguales
- d. Amygdales gastriques
- e. Amygdales mastoïdiennes

25. Dans la mastoïdite aiguë :

- a. Le traitement consiste en une stapédotomie
- b. Le traitement consiste en une antibiothérapie
- c. Le traitement consiste en une chirurgie reconstructive avec restauration de l'audition par tympanoplastie
- d. Le traitement consiste en une myringotomie
- e. Le traitement consiste en une mastoïdectomie

26. Les abcès liés à une infection mastoïdienne sont :

- a. Bezold
- b. Pétrosite
- c. Zygomatique
- d. Cellulite orbitaire
- e. Postauriculaire

27. Les symptômes de l'amygdalite aiguë sont :

- a. Respiration buccale
- b. Difficulté à avaler
- c. Fièvre
- d. Mal de gorge
- e. Mal d'oreille

28. L'hypopharynx est cliniquement subdivisé en :

- a. Corde vocale
- b. Pli ventriculaire
- c. Sinus piriforme
- d. Zone postcricoïde
- e. Paroi pharyngée postérieure

29. Les tumeurs bénignes du larynx sont :

- a. Chondrome
- b. Ostéome
- c. Hémangiome
- d. Botriomycome
- e. Papillome

30. Les lésions congénitales du larynx sont :

- a. Laryngomalacie
- b. Atrésie des choanes
- c. Rebord laryngé
- d. Fente palatine
- e. Laryngocèle

31. *Le sinus maxillaire :

- a. S'ouvre dans le méat supérieur
- b. Son innervation provient du IXe nerf crânien
- c. C'est le plus grand sinus
- d. S'ouvre dans le méat supérieur
- e. A une capacité de 5 ml

32. Les symptômes de la rhinite vasomotrice ne sont PAS :

- a. Obstruction nasale
- b. Bronchospasme
- c. Écoulement postnasal
- d. Respiration sifflante
- e. Prurit oculaire

33. Nodules vocaux :

- a. Sont considérées comme des réactions tissulaires tumorales.
- b. Plus fréquentes chez les patients de sexe masculin.
- c. Ne sont pas favorisées par une surcharge vocale.
- d. Sont traitées chirurgicalement.
- e. Le repos de la voix est recommandé.

34. Les complications d'un traumatisme laryngotrachéal sont représentées par :

- a. Perte du goût
- b. Périchondrite/abcès laryngé
- c. Paralysie des cordes vocales
- d. Sténose laryngée
- e. Hyposmie

35. Un traumatisme laryngotrachéal peut être représenté par :

- a. Hématome et œdème
- b. Othématome
- c. Luxation de l'articulation cricoaryténoïdienne
- d. Fractures des os hyoïdes, des cartilages thyroïdiens et cricoïdes
- e. Fractures des anneaux trachéaux supérieurs

36. Voici les complications intratemporales de l'otite moyenne :

- a. Abscess sous dural
- b. Paralyse faciale
- c. Mastoïdite
- d. Méningite
- e. Pétrosite

37. *Les structures de la paroi oropharyngée sont les suivantes, à une exception près :

- a. La muqueuse
- b. Aponévrose pharyngée
- c. Fascia musculaire
- d. Fascia buccopharyngé
- e. Périoste